Клинические рекомендации

# Хронический средний отит

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **H65.2** — Хронический серозный средний отит<br>**H65.3** — Хронический слизистый средний отит<br>**H65.4** — Другие хронические негнойные средние отиты<br>**H66.1** — Хронический туботимпанальный гнойный средний отит<br>**H66.2** — Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит<br>**H66.3** — Другие хронические гнойные средние отиты<br>**H72.0** — Центральная перфорация барабанной перепонки<br>**H90.0** — Кондуктивная потеря слуха двусторонняя<br>**H90.1** — Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе<br>**H90.2** — Кондуктивная потеря слуха неуточненная<br>**H90.6** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя<br>**H90.7** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя, с нормальным слухом на противоположном ухе<br>**H90.8** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость неуточненная |
| Пациенты | взрослые, дети |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 29.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/698_2 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Главное** ..... 3

**2. Клиника и классификация** ..... 3

2.1 Определение ..... 3

2.2 Причины ..... 3

2.3 Классификация ..... 4

2.4 Клиническая картина ..... 4

**3. Диагностика** ..... 4

3.1 Жалобы и анамнез ..... 4

3.2 Осмотр ..... 5

3.3 Степени мукозита при осмотре ..... 5

3.4 Слух: камертоны и аудиометрия ..... 6

3.5 Лучевая диагностика ..... 6

3.6 Лабораторные исследования ..... 7

3.7 Консультации ..... 7

**4. Лечение** 7
4.1 Консервативное лечение 8
4.2 Хирургическое лечение 9
4.3 Холестеатома: санирующие операции 10
4.4 Слухопротезирование 10
**5. Наблюдение, профилактика, госпитализация** 11
5.1 Госпитализация и выписка 11
**6. Источник и актуальность** 11
6.1 Неточности в самом тексте КР 12

## 1. Главное

- Основное лечение хронического гнойного среднего отита — хирургическое, и любой такой пациент — потенциальный кандидат на операцию. Оперируют в ремиссии, не раньше чем через 3–6 месяцев после последнего обострения.
- При диагностике всем делают тональную пороговую аудиометрию: она определяет степень и вид тугоухости и позволяет прогнозировать результат операции. Если пороги костной проводимости на разговорных частотах выше 30 дБ, качественного улучшения слуха не стоит ждать даже после безупречной операции.
- При подозрении на холестеатому или её рецидив назначают МРТ височных костей: в режимах T1, T2 и диффузионно-взвешенных изображениях она отличает холестеатому от секрета, грануляций и холестероловой гранулемы.
- В консервативном лечении главную роль играют местные средства — антисептики, ушные капли с противомикробными препаратами и кортикостероидами; топические фторхинолоны не ототоксичны и подходят при перфорации. Местное лечение работает только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.
- Неоперированных пациентов осматривают раз в 6 месяцев, а после тимпанопластики или санирующей операции — раз в год не меньше 5 лет, чтобы не пропустить рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

## 2. Клиника и классификация

### 2.1 Определение

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) — хроническое воспаление полостей среднего уха со стойкой перфорацией барабанной перепонки, постоянным или периодическим гноетечением из уха и прогрессирующим снижением слуха дольше 3 месяцев.

Мукозит — хроническое катаральное воспаление слизистой среднего уха. Тимпаносклероз — необратимый исход неспецифического воспаления с тугоухостью из-за фиксации звукопроводящей цепи. Тимпанофиброз — незаконченный процесс, при котором фиброзирование в барабанной полости преобладает над воспалением. Холестеатома — белесовато-перламутровое эпидермальное образование с оболочкой (матриксом), покрытой многослойным плоским эпителием; матрикс плотно прилежит к кости и нередко врастает в неё.

### 2.2 Причины

У взрослых ХГСО развивается на фоне хронических болезней полости носа, околоносовых пазух и носоглотки, после перенесённых острых средних отитов, при системной и специфической патологии. Запускает процесс обычно острый средний отит, после которого остаётся стойкая перфорация или ретракция с атрофичной неомембраной, а также травматическая или ятрогенная перфорация: после врачебных манипуляций она сохраняется у 1,3–10,8% пациентов.

Хронизации способствуют анатомические особенности среднего уха и слуховой трубы, неадекватная антибактериальная терапия острого отита без дренирования среднего уха, устойчивые штаммы возбудителей, ретракция после острого отита, экссудативный средний отит, ослабление местной иммунной защиты, а также болезни носоглотки и носа, нарушающие мукоцилиарный клиренс слуховой трубы.

Главный возбудитель среди аэробов — синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), второй по значимости — золотистый стафилококк. Из анаэробов чаще высевают пептококки и пептострептококки, реже бактероиды; анаэробы чаще сопутствуют холестеатоме. В 1,4–20% случаев флора грибковая, обычно Aspergillus и Candida.

### 2.3 Классификация

По МКБ-10 различают две формы ХГСО: мезотимпанит (туботимпанальный отит) и эпитимпанит (эпитимпано-антральный отит). При мезотимпаните поражается в основном слизистая мезо- и гипотимпанума, при эпитимпаните процесс из эпитимпанума распространяется в клетки сосцевидного отростка и поражает костные структуры среднего уха.

По клинико-морфологической классификации хронический средний отит бывает неперфоративным — экссудативным, адгезивным (рубцовым), с тимпаносклерозом или тимпанофиброзом — и перфоративным: сухим, с мукозитом, с тимпаносклерозом или с холестеатомой.

Место перфорации отражает только преимущественную локализацию воспаления и не говорит о том, что происходит в среднем ухе: даже при мезотимпаните цепь слуховых косточек разрушена у 10–22%, а холестеатома в барабанной полости есть у 11,6–42% пациентов. Поэтому для планирования операции эти изменения нужно диагностировать.

По классификации Европейской академии отологии и нейроотологии и Японского отологического общества (EAONO/JOS) различают 4 типа холестеатомы — врождённую, ненатянутой части, натянутой части перепонки и вторичную при перфорации натянутой части — и 4 стадии: 1 — в одном регионе, 2 — в двух и более, 3 — с внечерепным осложнением, 4 — с внутричерепным. Регионы обозначают по системе STAM: труднодоступные зоны (надтубарный и тимпанальный синусы), барабанная полость, аттик и сосцевидный отросток.

### 2.4 Клиническая картина

Пациенты жалуются на снижение слуха и шум в ухе; при осмотре видна перфорация барабанной перепонки с выделениями или холестеатомой.

Мезотимпанит — форма с перфорацией в натянутой части барабанной перепонки, встречается у 48–69% больных ХГСО. Её считают относительно благоприятной, потому что признаков активной остеодеструкции нет.

Эпитимпанит встречается у 15–19% больных: перфорация находится в ненатянутой части перепонки, в среднем ухе идёт кариозный процесс, который может привести к лабиринтным и внутричерепным осложнениям. Кость в 79–97% случаев разрушает холестеатома. Ретракционный карман считают начальной стадией холестеатомы: в 80% случаев она развивается именно из него.

При эпимезотимпаните, который выявляют у 17–33% пациентов, есть признаки обеих форм.

---

## 3. Диагностика

Диагноз ставят по совокупности жалоб, анамнеза, осмотра, лабораторных и инструментальных исследований.

### 3.1 Жалобы и анамнез

Пациента расспрашивают, снижен ли слух на одно или оба уха.

Снижение слуха отмечают 93–99% пациентов, чаще с двух сторон. При долгом течении, когда формируются тимпаносклероз, тимпанофиброз и ретракционный карман, тугоухость становится выраженной.

Уточняют, как долго, как часто и какие бывают выделения из уха.

Оторея — вторая по значимости жалоба, она бывает у 76–100% пациентов. Около половины отмечают выделения 1–2 раза в год после переохлаждения, попадания воды в ухо или ОРЗ, почти треть — частые или постоянные выделения в последние годы. Выделения бывают от скудных слизистых до гнойных с ихорозным запахом.
Редкие обострения при выраженной тугоухости характерны для тимпаносклероза, тимпанофиброза и холестеатомы, постоянные выделения — для мукозита, гнойные выделения с неприятным запахом — для холестеатомы. Эпитимпанит опасен тем, что долго протекает бессимптомно.

Спрашивают о шуме в одном или обоих ушах.

Шум беспокоит 19–48% пациентов. Низкочастотный шум обычно связан с дефектом перепонки, высокочастотный — с поражением внутреннего уха. При тимпаносклерозе и тимпанофиброзе шум усиливается.

Спрашивают о заложенности, ощущении жидкости и дискомфорте в ухе.

Такие жалобы чаще бывают, когда натянутая часть барабанной перепонки сохранена.

Спрашивают о головокружении в прошлом.

Системное головокружение или неустойчивость бывают у 10–27% больных с холестеатомой — при обострении, нагрузке, наклонах и поворотах головы. В половине случаев это говорит о фистуле лабиринта. Если разрушена стенка канала лицевого нерва, возможен его парез.

Спрашивают о головной боли.

Головная боль разной локализации часто появляется при обострении. Для неосложнённого эпитимпанита боль в ухе и головная боль не характерны: обычно они означают, что возникло осложнение.

### 3.2 Осмотр

Всем выполняют отоскопию или видеоотоскопию: при ХГСО это определяющий метод диагностики вместе с отоэндоскопией.

Оценивают барабанную перепонку (тонкая, толстая, рубцовая, очаги тимпаносклероза), ретракционные карманы и их глубину, размер и место перфорации и её края, слизистую барабанной полости (мукозит, тимпаносклероз, полипы, грануляции, эпидермизация), видимые слуховые косточки (кариес, лизис), латеральную стенку аттика и адитус.

### 3.3 Степени мукозита при осмотре

| Степень | Что видно |
|---|---|
| I | Слизистая медиальной стенки барабанной полости утолщена, свободного отделяемого нет |
| II | Подушкообразное утолщение слизистой медиальной стенки с большим количеством слизистых желёз и скудным слизистым отделяемым |
| III | Выраженная полиповидная гиперплазия слизистой мезогипотимпанума со слизистым отделяемым |

Отоэндоскопия позволяет увидеть холестеатому в 61% случаев. При эпитимпаните перфорация бывает точечной, видна только при продувании, прикрыта серной коркой или временно отсутствует в стойкой ремиссии — тогда внимательно осматривают латеральную стенку аттика в поисках даже минимальной деструкции. Иногда болезнь маскируется под рецидивирующий экссудативный отит, а за прозрачным экссудатом виден холестеатомный мешок при небольшом ретракционном кармане в ненатянутой части. Глубокие карманы осматривают эндоскопами с углом обзора 0°, 30° и 70°.

Фистулу лабиринта помогает распознать фистульная проба.

Проходимость слуховой трубы проверяют пустым глотком, пробой Тойнби, приёмом Вальсальвы или продуванием баллоном Политцера. Чем сильнее мукозит, тем хуже вентиляционная и дренажная функции трубы. Дисфункция трубы может объяснять ретракцию перепонки до операции и в отдалённом послеоперационном периоде, её учитывают при хирургии и реабилитации. Если при хроническом серозном отите с трубой всё в порядке, нужно заподозрить спонтанную отоликворею.

Оценивают полость носа, околоносовые пазухи и носоглотку: искривление перегородки, гипертрофический ринит, хронические болезни пазух и носоглотки нарушают функцию слуховых труб и снижают эффективность лечения.

### 3.4 Слух: камертоны и аудиометрия

При подозрении на снижение слуха исследуют слух камертонами.

Количественные (камертоны С128–2048) и качественные (С128–512) пробы Ринне, Федериче и Вебера — скрининг, который показывает вид тугоухости, кондуктивной или сенсоневральной, и хуже слышащее ухо. По ним составляют слуховой паспорт; они же служат показанием к тональной пороговой аудиометрии.

При диагностике ХГСО выполняют тональную пороговую аудиометрию (ТПА).

ТПА точно определяет степень и вид тугоухости — кондуктивную, смешанную или нейросенсорную — и возможности реабилитации, позволяет прогнозировать результат операции и следить за ним в отдалённом периоде. Если пороги костной проводимости выше 30 дБ в диапазоне разговорных частот, качественного улучшения слуха нельзя ожидать даже после идеально выполненной операции. Динамику лучше оценивать на одном и том же аудиометре и одному и тому же исследователю.

Для ХГСО характерна кондуктивная и смешанная тугоухость; её степень зависит от дефекта перепонки, целости и подвижности цепи слуховых косточек и токсического действия воспаления на внутреннее ухо. Глухота при ХГСО часто связана с фистулой лабиринта из-за разрушения кости холестеатомой.

По аудиограмме холестеатому не распознать: костно-воздушный интервал не коррелирует с вариантом разрушения цепи, а холестеатома и грануляции сами могут проводить звук к внутреннему уху.

### 3.5 Лучевая диагностика

При ХГСО без холестеатомы для оценки сосцевидного отростка можно сделать рентгенографию височных костей в укладках по Шюллеру и Майеру.

Её делают, только если нет подозрения на холестеатому и осложнённого течения.

Пациентам с ХГСО выполняют компьютерную томографию (КТ) височных костей, чтобы оценить их структуры.

КТ — метод первичной диагностики. Она показывает распространённость процесса и анатомические особенности — низкое стояние дна средней черепной ямки, высокое стояние луковицы яремной вены, предлежание сигмовидного синуса, дегисценции лицевого канала и лабиринта, перегородку Кёрнера, — а также стенки барабанной полости и антромастоидального отдела, цепь косточек, слизистую и узкие пространства барабанной полости. Исследование проводят в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией; идеальная толщина среза — 0,5–0,8 мм.

КТ выявляет признаки ХГСО в 99% случаев, деструкцию стенок среднего уха — в 55–97%. Отличить холестеатому от фиброза, грануляций, экссудата и гноя по плотности нельзя: у всех она от +30 до +40 HU. Заподозрить холестеатому в 88% случаев позволяют расположение образования, разрушение стенок барабанной полости, косточек и антромастоидальной области, расширение входа в антрум, разрушение латеральной стенки аттика или адитуса, дефект задней стенки слухового прохода, разрушение лицевого канала и фистула лабиринта, чаще горизонтального полукружного канала.

При ХГСО без холестеатомы на КТ видны изменения слизистой, рубцы вокруг цепи косточек, иногда её дефект — чаще из-за лизиса длинной ножки наковальни. Антрум при мезотимпаните в ремиссии обычно пневматизирован, сосцевидный отросток, как правило, компактный, склеротический.

Оперированное ухо КТ оценивает плохо: рубцы, грануляции и пластический аутоматериал по плотности не отличаются от холестеатомы. Заподозрить её можно только по росту «подозрительного» образования в динамике.

Чтобы объективно оценить распространённость процесса, КТ делают не раньше чем через 3–6 месяцев после обострения. КТ в период обострения необоснованно расширяет объём операции и оправдана только при осложнённом течении.

При подозрении на холестеатому или её рецидив выполняют магнитно-резонансную томографию (МРТ) височных костей.

В режимах T1, T2, EPI DWI и non-EPI DWI МРТ надёжно выявляет холестеатому и её рецидив после операции: чувствительность 77–100%, специфичность 86–100%. За холестеатому говорят низкий сигнал в T1 и высокий или средний — в T2 и non-EPI DWI. На точность влияет размер холестеатомы; для поиска рецидива МРТ выгоднее ревизионной операции и служит ей альтернативой.

Некоторые авторы для поиска холестеатомы советуют сочетать или совмещать КТ и МРТ: чувствительность тогда 96%, специфичность 100%.

При ХГСО с холестеатомой, осложнённой фистулой лабиринта, проводят вестибулометрию.

Её назначают при системном головокружении, неустойчивости и признаках фистулы. Если фистулу найти до операции, можно предупредить послеоперационные кохлеовестибулярные расстройства.

### 3.6 Лабораторные исследования

Общие лабораторные анализы выполняют при подготовке к плановой операции.

Отделяемое из уха сеют на аэробную и факультативно-анаэробную флору и определяют чувствительность к антимикробным препаратам.

Посев нужен при любом ХГСО, чтобы подобрать этиотропную терапию.

При подозрении на грибковый процесс отделяемое из ушей сеют на дрожжевые и мицелиальные грибы.

Удалённые ткани уха исследуют цитологически и патоморфологически.

Патоморфологическое исследование делают всякий раз, когда удаляют патологическую ткань. При атипичном воспалении спектр анализов расширяют, чтобы исключить туберкулёз и гранулематоз Вегенера; если ответа нет, а стандартное лечение не помогает, исследования повторяют через 3 месяца.

### 3.7 Консультации

При сопутствующих болезнях и подозрении на осложнение пациента консультируют невролог, нейрохирург и терапевт.

При атипичном воспалении и осложнениях могут понадобиться также фтизиатр и ревматолог.

---

## 4. Лечение

Цель лечения — санировать среднее ухо, чтобы добиться стойкой ремиссии и предупредить осложнения и тугоухость.

### 4.1 Консервативное лечение

Консервативную терапию проводят при обострении и для подготовки к операции при неосложнённом течении.

Её назначают при обострении, чтобы добиться ремиссии перед операцией, и в раннем периоде после санирующей операции. Она включает бета-лактамные антибиотики, анальгетики, кортикостероиды и процедуры для улучшения функции слуховой трубы.
При неосложнённом течении лечат амбулаторно, при осложнённом — в стационаре. Как основное лечение консервативная терапия носит паллиативный характер и оправдана только у пациентов с тяжёлыми сопутствующими болезнями при регулярном наблюдении.

При сухом перфоративном среднем отите никакого лечения не проводят.

> Расхождение в КР: в разделе 3.1 сказано, что при сухом перфоративном отите лечения не проводят, а в разделе 3.2 — что при перфорации без возможности улучшить слух тимпанопластику нужно выполнять, чтобы предупредить рецидивы, и что лучшие результаты тимпанопластики бывают именно при сухих перфорациях. В алгоритме (приложение Б) от сухого перфоративного отита стрелки ведут к лечению. Вероятно, запрет относится только к консервативной терапии.

Антибиотик выбирают с учётом флоры, её чувствительности и способности препарата проникать через гематоэнцефалический барьер. Препараты выбора — бета-лактамы (пенициллины и другие бета-лактамные антибиотики), в некоторых случаях — респираторные фторхинолоны.

Системные препараты назначают, как правило, при выраженном обострении и при тяжёлых распространённых деструктивных формах. Периоперационная антибиотикопрофилактика должна соответствовать характеру и объёму операции.

При смешанной флоре КР советует сочетать 2–3 препарата, например цефалоспорины и фторхинолоны. Возможно сочетание местных противомикробных препаратов с противогрибковыми.

Главная роль в лечении принадлежит местным средствам: антисептикам, ушным противомикробным препаратам, местным противогрибковым средствам и кортикостероидам в комбинации с противомикробными. Самые эффективные и безопасные — топические фторхинолоны: к ним чувствительны 75,6% возбудителей, они не ототоксичны и подходят при перфорации. Местное лечение действует только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.

Грануляции в барабанной полости по возможности удаляют или прижигают соединениями серебра; они хорошо регрессируют и под действием топических кортикостероидов.

Кортикостероиды в каплях или в комбинированных препаратах назначают при вялотекущем воспалении слизистой (мукозите). Если местное лечение не помогает 1–3 месяца, что характерно для мукозита, выполняют операцию с дренированием.

При холестеатоме местно эффективны препараты борной кислоты: кроме антисептического действия, они подсушивают ткани и этим уменьшают воспаление.

При грибковой флоре противомикробные препараты и кортикостероиды в каплях противопоказаны. Таких пациентов ведут строго по алгоритмам применения местных противогрибковых средств; лечение часто долгое и требует участия миколога.

> Расхождение в КР: абзацем выше КР допускает сочетать противомикробные ушные препараты с противогрибковыми, а здесь при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны. Кроме того, «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом АТХ D01A, который относится к противогрибковым препаратам.

Дисфункцию слуховой трубы лечат по порядку. Сначала устраняют болезни носа и носоглотки — от деконгестантов и назальных кортикостероидов до операции. Затем улучшают проходимость трубы продуванием по Политцеру или курсом катетеризаций с введением лекарств. Наконец, налаживают её самостоятельное открытие и закрытие специальной гимнастикой или электростимуляцией мышц трубы.

### 4.2 Хирургическое лечение

Основное лечение ХГСО — хирургическое: только операция позволяет полностью санировать ухо и улучшить качество жизни, поэтому любой пациент с ХГСО — потенциальный кандидат на неё. Оперируют в ремиссии, не раньше чем через 3–6 месяцев после последнего обострения: так операция меньше по объёму, безопаснее и эффективнее.

Вынужденная операция при обострении или осложнении — это только санация среднего уха открытого типа, при внутричерепных осложнениях расширенная; из-за кровоточивости тканей она технически сложна и чаще даёт ятрогенные осложнения. Пациентов с осложнениями оперируют в ургентных отделениях, вне обострения — в специализированных отделениях и центрах, где владеют реконструктивной хирургией среднего уха. Ранняя операция на «сухом ухе» лучше санирует очаг, сохраняет слух и анатомию и сокращает реабилитацию.

При ХГСО с мукозитом II и III степени выполняют дренирующие операции.

Методику выбирают индивидуально: по форме ХГСО и распространённости процесса, анатомии височной кости, степени тугоухости, состоянию слуховой трубы, осложнениям и опыту хирурга.

Чтобы санировать среднее ухо и улучшить слух, выполняют тимпанопластику.

При мезотимпаните делают тимпанопластику разных типов и миринготомию в зависимости от разрушения цепи косточек, используя протезы из хряща, наковальни, кортикальной кости, титана и аутоматериалы для пластики перепонки. Доступ — через слуховой проход, эндауральный или заушный, под местной анестезией или наркозом, под эндоскопом или микроскопом, в один или два этапа.
Результат зависит от времени после последнего обострения, изменений в среднем ухе, места и размера перфорации, функции слуховой трубы и состояния слизистой, способа реконструкции, опыта хирурга и послеоперационного ведения. Обязательное условие успешной тимпанопластики — отсутствие выделений минимум 3–6 месяцев.

Тимпанопластика эффективна в 43–98% случаев; риск глухоты оперированного уха — 1–2%. Лучшие результаты, у 93,3%, бывают при сухих перфорациях, независимо от техники укладки трансплантата.

Мастоидотомия при тимпанопластике у пациентов без холестеатомы не улучшает ни анатомический результат, ни аэрацию сосцевидного отростка, но увеличивает объём и риск операции. Обязательной её считают при вялотекущем хроническом перфоративном отите без холестеатомы, если системные и местные антибиотики не помогли.

Эндоскоп как дополнение к микроскопу улучшает обзор барабанной полости, но преимущества операций только под эндоскопом перед микроскопом по данным систематического обзора не доказаны.

При тотальных и субтотальных дефектах перепонки с изменённой слизистой большинство хирургов сочетают аутофасцию, аутохрящ и кожные трансплантаты, чтобы не было реперфорации. Тонкие пластинки аутохряща препятствуют ретракции и не ухудшают акустику.

При мукозите тимпанопластика оправдана: после восстановления функции трубы и аэрации утолщённая слизистая становится нормальной. Слизистую удаляют инструментами или лазером. При выраженном мукозите лучше результаты, если оставить дренажную трубку под меатальным лоскутом или вскрыть антрум и дренировать через него барабанную полость до 2 недель.

Второй этап тимпанопластики выполняют через 8–12 месяцев. Если перфорация есть, а слух улучшить нельзя, тимпанопластику всё равно делают, чтобы предупредить рецидивы ХГСО.

Искусственные протезы и аутопротезы при оссикулопластике по слуху не различаются, но искусственный протез без прикрытия аутохрящом смещается в 6 раз чаще.

### 4.3 Холестеатома: санирующие операции

При ХГСО с холестеатомой выполняют санирующие операции.

Главный принцип — удалить холестеатому полностью и устранить причины рецидива.

При эпитимпаните и эпимезотимпаните с холестеатомой в зависимости от распространённости выполняют «открытые», «полуоткрытые» или «закрытые» санирующие операции с тимпанопластикой или без неё. Из-за объёма и длительности их делают под общей анестезией.

Если холестеатома ограничена аттиком или аттиком и адитусом, можно ограничиться аттикотомией через слуховой проход, но обязательно тщательно убрать процесс из синусов и карманов среднего уха.

«Открытая» техника (с удалением задней стенки слухового прохода) избавляет от повторных операций, но не от регулярного ухода за полостью у оториноларинголога. После «закрытой» обязательна ревизия через 8–12 месяцев или МРТ для исключения рецидива. «Закрытые» операции опаснее внутричерепными осложнениями, поэтому, если постоянное наблюдение после операции невозможно, предпочтительна «открытая» методика.

«Закрытые» методики (аттикоадитотомия, аттикоантротомия, раздельная антромастоидотомия) предпочтительны при ограниченной холестеатоме, «открытые» (модифицированная радикальная, консервативно-радикальная, общеполостная операция, антромастоидотомия с удалением задней стенки, радикальная мастоидэктомия) — при распространённой деструкции, активной холестеатоме или вялотекущем обострении.

Современная тенденция — «полуоткрытая» (гибридная) техника: аттикоантро- или мастоидотомия с облитерацией антрума и сосцевидного отростка аутотканями или инертными материалами и тимпанопластикой. Анатомия уха остаётся близкой к исходной, болезни послеоперационной полости нет, и пожизненное наблюдение не нужно.

> Неточность в КР: частота рецидивов холестеатомы напечатана с ошибками — «у 342%» после «закрытой» и «у 712%» после «открытой» техники, видимо, потеряно тире в диапазонах. Сразу после этого сказано, что при «открытой» технике рецидивов меньше, но «эта техника» повышает риск рецидива в 2,9 раза по сравнению с «закрытой» и поэтому рекомендуется только при повторных операциях. По приведённым цифрам чаще рецидивирует «закрытая» техника, так что фраза противоречива.

Если после «закрытой» операции найден рецидив холестеатомы, объём операции расширяют до антромастоидотомии с удалением задней стенки слухового прохода и формированием открытой полости.

После операции слуховой проход тампонируют с противомикробными препаратами: после тимпанопластики на 10–14 дней, после санирующей операции — на 14–21 день; дополнительно воздействуют на слуховую трубу и слизистую лекарствами и физиотерапией. Важно и квалифицированное наблюдение в отдалённом периоде.

### 4.4 Слухопротезирование

Если слух асоциальный (тугоухость больше II степени) и улучшить его нельзя, проводят электроакустическую реабилитацию.

Слухопротезирование показано при порогах костной проводимости выше 30 дБ на оба уха, в том числе в отдалённом периоде после операции.

## 5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациентов, которым операция противопоказана, отложена или которые от неё отказались, наблюдает специалист поликлиники раз в 6 месяцев, а при обострении назначает консервативное лечение.

После тимпанопластики и санирующих операций пациент раз в год приходит к врачу поликлиники и к отохирургу клиники, где его оперировали, не меньше 5 лет после операции. Цель — вовремя найти рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

Для профилактики обострений санируют нос и носоглотку, объясняют пациенту характер болезни, учат беречь ухо от воды и предупреждать обострения при ОРЗ и своевременно обращаться к врачу поликлиники и в клинику, где была операция.

После операции, в зависимости от методики, назначают постельный режим с положением на противоположном ухе. Месяц нужно избегать физических нагрузок, 3 месяца — авиаперелётов, а ухо беречь от воды до конца реабилитации.

### 5.1 Госпитализация и выписка

Пациента первично осматривают оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

Экстренно госпитализируют при обострении ХГСО с внечерепными или внутричерепными осложнениями.

Планово госпитализируют для операции при ХГСО, в том числе с холестеатомой, в стадии вялотекущего воспаления или ремиссии не меньше 3–6 месяцев. Показания — снижение слуха с шумом в ухе, снижение слуха со скудными выделениями, которые не проходят от консервативного лечения, или любые клинические проявления ХГСО независимо от вида тугоухости, если нет общих противопоказаний и пациент обследован по требованиям стационара.

После экстренной госпитализации выписывают, когда угрозы жизни нет и жизнедеятельность восстановлена, после плановой — в зависимости от объёма операции и самочувствия: на 3–5-й день после окончания противовоспалительной и симптоматической терапии, с тампонами в слуховом проходе. Тампоны удаляют амбулаторно через 2–3 недели, а слух по ТПА проверяют амбулаторно через 3 и 12 месяцев.

Эффективность лечения оценивают по жалобам на снижение слуха и выделения, по отоэндоскопии (закрылась ли перфорация, нет ли отореи, эпидермизирована ли полость), по ТПА, по КТ или МРТ (санировано ли ухо, нет ли деструкции и холестеатомы) и по вестибулометрии при фистуле лабиринта.

ХГСО ведёт к прогрессирующей тугоухости и осложнениям: лабиринтиту, периферическому парезу лицевого нерва, менингиту, абсцессу мозга и тромбозу сигмовидного синуса.

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Хронический средний отит» |
| Версия | 2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 29.10.2024 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года |
| Код в рубрикаторе | 698_2 · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Пациенты | Взрослые и дети |

### 6.1 Неточности в самом тексте КР

- При сухом перфоративном среднем отите раздел 3.1 запрещает любое лечение, а раздел 3.2 и алгоритм в приложении Б предусматривают при перфорации тимпанопластику.
- Сочетание противомикробных ушных препаратов с противогрибковыми допускается, но при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны; «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом противогрибковых препаратов D01A.
- Частота рецидивов холестеатомы напечатана с ошибками («у 342%», «у 712%», «4,28,4%»), а вывод о том, что «открытая» техника повышает риск рецидива в 2,9 раза, противоречит приведённым цифрам.
- Сроки тампонады после операции различаются: в разделе 3.2 — 10–14 дней после тимпанопластики и 14–21 день после санирующей операции, в разделе 6 — удаление тампонов через 2–3 недели.
- Название и коды МКБ охватывают и негнойные формы (H65.2–H65.4), но определение и весь текст КР посвящены только хроническому гнойному среднему отиту.
- В рекомендации о дренирующих операциях мукозит разделён на «стадии», хотя при осмотре описаны его «степени».
- В критериях качества у консервативного лечения указан УДД 4, а в самой рекомендации — УДД 5; критерия «хирургическое лечение при неэффективности консервативной терапии» в рекомендациях нет, по тексту КР операция — основное лечение.
- В оглавлении PDF номера страниц многих разделов искажены («100», «133», «232» и т. п.).